



Interativa

Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem

Autoras: Profa. Gabriela Rodrigues Zinn
Profa. Miriam Sanches do Nascimento Silveira
Profa. Daniele Porto Barros
Profa. Débora Gomes Barros
Profa. Carla Garcia Gomes Lecca
Profa. Monique Martins

Colaboradoras: Profa. Renata Guzzo Souza
Profa. Laura Cristina da Cruz Dominciano

Professoras conteudistas: Gabriela Rodrigues Zinn / Miriam Sanches do Nascimento Silveira / Daniele Porto Barros / Débora Gomes Barros / Carla Garcia Gomes Lecca / Monique Martins

Gabriela Rodrigues Zinn

Doutora em Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem e em Saúde pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Enfermagem Gerontológica pela Universidade de São Paulo e enfermeira graduada em 2001 pela Universidade de São Paulo. Atuou como enfermeira assistencial em Unidade de Terapia Intensiva no Hospital da Universidade de São Paulo. É docente da Universidade Paulista desde 2004 e coordena os cursos de graduação no *campus* Alphaville e pós-graduação em Enfermagem no *campus* Sorocaba.

Miriam Sanches do Nascimento Silveira

Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Sorocaba, especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de São Camilo e em Doação de Órgãos de Tecidos para Transplante pela Universidade Albert Einstein e enfermeira graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou como enfermeira assistencial em Unidade de Pronto-Socorro.

Daniele Porto Barros

Doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em Enfermagem Hospitalar à Criança e ao Adolescente pela Universidade de São Paulo e graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. Atuou como coordenadora de enfermagem na Unidade de Transplante de Medula Óssea do Instituto de Oncologia Pediátrica.

Débora Gomes Barros

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, especialista em Enfermagem do Trabalho pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e enfermeira graduada pela Universidade de São Paulo. Atuou como enfermeira assistencial em Unidade de Clínica Médico-Cirúrgica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Carla Garcia Gomes Lecca

Mestre em Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem e em Saúde pela Universidade de São Paulo, especialista em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Docência do Ensino Técnico e Superior pela Faculdade Inesp (Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa) e em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva pelo Centro Universitário São Camilo. Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São Paulo. Atuou como enfermeira assistencial em Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Sepaco e no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É docente da Universidade Paulista desde 2011.

Monique Martins

Pós-graduada em Estomaterapia pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Enfermagem Clínica e Cirúrgica pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou como enfermeira assistencial e de reabilitação no Instituto de Reabilitação Lucy Montoro – Fundação Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas. Proprietária da empresa Stay Care Sorocaba – clínica especializada em Estomaterapia e Podiatria.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Z78a Zinn, Gabriela Rodrigues.

Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem. / Gabriela Rodrigues Zinn. – São Paulo: Editora Sol, 2019.

140 p., il.

Nota: este volume está publicado nos Cadernos de Estudos e Pesquisas da UNIP, Série Didática, ano XXV, n. 2-005/19, ISSN 1517-9230.

1. Avaliação clínica. 2. Avaliação psicossocial. 3. Promoção da Saúde. II. Título.

CDU 616-083

W501.74 – 19

Prof. Dr. João Carlos Di Genio

Reitor

Prof. Fábio Romeu de Carvalho

Vice-Reitor de Planejamento, Administração e Finanças

Profa. Melânia Dalla Torre

Vice-Reitora de Unidades Universitárias

Prof. Dr. Yugo Okida

Vice-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Profa. Dra. Marília Ancona-Lopez

Vice-Reitora de Graduação

Unip Interativa – EaD

Profa. Elisabete Brihy

Prof. Marcelo Souza

Prof. Dr. Luiz Felipe Scabar

Prof. Ivan Daliberto Frugoli

Material Didático – EaD

Comissão editorial:

Dra. Angélica L. Carlini (UNIP)

Dra. Divane Alves da Silva (UNIP)

Dr. Ivan Dias da Motta (CESUMAR)

Dra. Kátia Mosorov Alonso (UFMT)

Dra. Valéria de Carvalho (UNIP)

Apoio:

Profa. Cláudia Regina Baptista – EaD

Profa. Betisa Malaman – Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos

Projeto gráfico:

Prof. Alexandre Ponzetto

Revisão:

Vitor Andrade

Ricardo Duarte

Sumário

Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem

APRESENTAÇÃO	7
INTRODUÇÃO	7

Unidade I

1 ENFERMAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL.....	11
1.1 Promoção da saúde.....	13
1.2 Pensamento crítico e pensamento reflexivo.....	17
2 AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	19
2.1 Consulta de Enfermagem	22

Unidade II

3 INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO CLÍNICA	30
3.1 Entrevista.....	31
3.2 Técnicas propedêuticas.....	38
3.2.1 Inspeção.....	38
3.2.2 Palpação	39
3.2.3 Percussão.....	40
3.2.4 Ausculta	41
4 AVALIAÇÃO DOS SINAIS VITAIS	41
4.1 Pressão arterial.....	41
4.1.1 Crianças	45
4.1.2 Idosos.....	45
4.1.3 Obesos	46
4.1.4 Gestantes	46
4.2 Pulso	46
4.3 Frequência respiratória	47
4.4 Temperatura.....	48
4.5 Dor.....	48

Unidade III

5 AVALIAÇÃO DO SISTEMA NEUROLÓGICO.....	56
5.1 Avaliação do estado mental.....	56
5.2 Distúrbios das funções cerebrais superiores	56
5.3 Avaliação do nível de consciência.....	57

5.4 Avaliação pupilar.....	59
5.5 Avaliação do controle do equilíbrio.....	59
5.6 Avaliação da função motora	60
5.7 Avaliação da função sensitiva.....	61
6 OUTRAS AVALIAÇÕES	62
6.1 Avaliação do sistema cardiocirculatório	62
6.2 Avaliação do sistema respiratório	64
6.3 Avaliação do sistema gastrointestinal.....	68
6.4 Avaliação do sistema geniturinário	71
6.5 Avaliação do sistema genital masculino.....	74
6.6 Avaliação do sistema genital feminino.....	75
6.6.1 Inspeção da genitália interna	79
6.7 Avaliação tegumentar	79
6.7.1 Histologia da pele.....	79
6.7.2 Funções da pele	82
6.7.3 Critérios de avaliação da pele.....	82

Unidade IV

7 RACIOCÍNIO CLÍNICO	87
7.1 Introdução à interpretação dos dados	90
7.2 Introdução às práticas de intervenção.....	92
7.2.1 Higiene das mãos.....	92
7.2.2 Higienização simples das mãos.....	95
7.2.3 Higienização antisséptica das mãos	96
7.2.4 Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos	97
7.3 Higiene corporal	98
8 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO.....	101
8.1 Medidas de prevenção	110
8.2 Avaliação da lesão por pressão.....	113
8.2.1 Mensuração das lesões: comprimento x largura x profundidade.....	115
8.2.2 Tratamento das lesões por pressão.....	115

APRESENTAÇÃO

O presente livro-texto tem como meta a imersão do leitor na sustentação teórica para a realização da avaliação clínica e psicossocial do ser humano. Para isso, apresentará alguns conceitos e discussões que possibilitam a construção do conhecimento nessa área.

Além disso, almeja suscitar a reflexão sobre a importância da realização de uma avaliação de qualidade como base para a atuação do profissional enfermeiro nas diferentes áreas de atenção à saúde.

Esperamos que, ao fim de nosso percurso de ensino/aprendizagem, seja compreensível a relação indissociável entre habilidade de relacionamento interpessoal e competência técnico-científica nas ações de saúde, para uma prática cada vez mais consciente e efetiva de cuidado com o outro.

Desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes pertinentes para uma avaliação integral do ser humano são elementos vitais para um cuidado de qualidade.

INTRODUÇÃO

A disciplina *Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem* tem como proposta subsidiar a construção do conhecimento acerca da avaliação do ser humano em seus aspectos clínicos e psicossociais a partir da compreensão da pessoa como sujeito ativo no processo de atenção à saúde.

Os objetivos da disciplina são:

- propiciar ao discente o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para avaliar o ser humano em seu aspecto psicossocial;
- proporcionar ao discente o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para avaliar o ser humano em seu aspecto clínico;
- iniciar o processo de raciocínio clínico e psicossocial diante dos dados obtidos na avaliação;
- inserir o raciocínio clínico e psicossocial desenvolvido para iniciar a compreensão do processo de Enfermagem;
- iniciar a realização de procedimentos essenciais para desenvolver habilidades práticas que subsidiarão outras mais complexas.

O processo de cuidar em Enfermagem, enquanto arte e ciência, requer competência técnica e científica permeada pela sensibilidade humana. Além disso, como o próprio nome diz, trata-se de um processo que é contínuo e único para cada ser humano que está sendo cuidado.

Conforme preconizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em sua Resolução nº 358/2009, o processo de cuidar em Enfermagem ocorre em cinco etapas:

- coleta de dados de Enfermagem;
- diagnóstico de Enfermagem;
- planejamento de Enfermagem;
- implementação;
- avaliação de Enfermagem.

Essa sistematização é estabelecida como estratégia de qualificação do cuidado; trata-se de um caminho a ser seguido na nossa prática profissional e que nunca se repete, já que o ser humano é sempre único.

Como diz Arantes (2016), as doenças se repetem, mas o sofrimento que elas geram no ser humano nunca é o mesmo; trata-se de experiência singular. A ciência se repete, é replicável, entretanto a arte, quando replicada, passa a ser plágio, pirataria. Dessa forma, devemos usufruir de toda a riqueza científica produzida, porém, é fundamental que a aplicação dessa ciência seja realizada a partir de uma atitude artística, única e sensível.

Nesse sentido, independentemente da condição de saúde ou doença, a experiência da vida humana é singular e deve ser respeitada e cuidada com essa delicadeza do olhar ampliado e ao mesmo tempo individual.

Na prática do cuidado do enfermeiro, seguindo o processo estabelecido pelo nosso Conselho de classe profissional, o Cofen, temos como primeiro momento a coleta de dados de Enfermagem, também chamada de Histórico de Enfermagem. Essa etapa do processo será o disparador de todos os demais passos do cuidado; é a partir desse momento que as necessidades de atenção e intervenção serão estabelecidas, implementadas, avaliadas e novamente estabelecidas em um ritmo contínuo.

Portanto, especial importância deve ser dada a esse momento do cuidado. É aqui que a disciplina de *Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem* se apresenta como subsídio no desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes para a vivência competente e sensível do enfermeiro e para a realização de um adequado levantamento de dados.

Para tanto, alguns aspectos devem ser destacados:

- Visão ampliada do ser humano: ser que ultrapassa a perspectiva biológica e contempla a dimensão psíquica, incluindo as emoções; a dimensão social, de vida familiar, de trabalho e demais inserções sociais; a dimensão histórica, política e econômica, que impacta diretamente na sua condição de saúde/doença; além da sua dimensão espiritual, que contempla o sentido dado à vida e às diferentes formas de vivenciar essa espiritualidade.

- Habilidade de relacionamento interpessoal: chave para que ocorra um levantamento de dados efetivo, oposto a uma prática burocrática.
- Competência técnica, científica, ética e humana: essência para um raciocínio clínico e psicossocial capaz de evidenciar as reais necessidades de atenção e cuidado.

Nesse sentido, apresentamos este livro-texto e convidamos você, aluno, a vivenciar essa experiência de abordar a vida humana de forma competente e sensível.

Unidade I

1 ENFERMAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL

Iniciaremos nosso percurso com uma reflexão acerca da atuação do enfermeiro no cuidado do ser humano inserido na sociedade, com destaque para a importância do levantamento de dados como etapa importante do processo de cuidar em Enfermagem.

A Enfermagem vem ampliando, crescentemente, o seu espaço de atuação na área da saúde, tanto no contexto nacional quanto no cenário internacional. O enfermeiro assume um papel cada vez mais decisivo e proativo no que se refere à identificação das necessidades de cuidado da população, bem como na promoção e proteção da saúde de indivíduos, famílias e comunidades (STEIN-BACKES *et al.*, 2014, p. 563).

Como elemento essencial nos sistemas de saúde, temos o cuidado prestado pelo enfermeiro, em especial, considerando a complexidade e as expectativas acerca das demandas de saúde da população. No movimento oposto ao foco na doença, temos a orientação para a promoção da saúde, que demanda novas habilidades e competências profissionais do enfermeiro na área social e política. Dessa forma, há um estímulo desse profissional no sentido da busca do desenvolvimento responsável. As habilidades e competências desenvolvidas incluem o direcionamento para a promoção da saúde, o monitoramento e o controle de doenças crônicas, em níveis locais, regionais, nacionais e internacionais (STEIN-BACKES *et al.*, 2014).

Para que o cuidado de Enfermagem possa atender à finalidade social da prática e articular os elementos técnico e ético desse cuidado, é necessário que o enfermeiro, em seu cotidiano de trabalho, conjugue princípios e valores com competência técnica. Deve haver uma dimensão de corresponsabilização e acolhimento. Para isso, é fundamental que os enfermeiros desenvolvam sensibilidade humana, a qual se manifesta no interesse, no respeito, na atenção, na compreensão, na consideração e no afeto pelo outro e pela comunidade (ZOBOLI; SCHVEITZER, 2013).

Além disso, é necessário que haja engajamento político na transformação do que é incompatível com a dignidade do ser humano, para que seja possível eliminar as desigualdades e fomentar os elementos que qualificam a vida (ZOBOLI; SCHVEITZER, 2013).

É evidente a importância da atuação da Enfermagem no âmbito individual, mas em especial no espaço comunitário e social. A Enfermagem pode atuar com criatividade e autonomia em diversos cenários de inserção social, a partir da educação em saúde, promovendo saúde, ou a partir de ações de prevenção de doenças e reabilitação da saúde. Esse processo ocorre, essencialmente, pautado no levantamento de situações críticas, mas também no planejamento e execução de intervenções

sistematizadas que superem a fragmentação do cuidado e garantam a continuidade do cuidado qualificado em saúde (TREZZA; SANTOS; LEITE, 2008; BACKES, 2008).

O que dá sentido à Enfermagem como prática social é o ordenamento para o bom cuidado; a ordem e a organização são fulcrais no bem-cuidar. Assim, manter redes, serviços, equipes e processos de produção em saúde organizados, ou seja, em ordem, parece ser importante para diminuir o desgaste dos enfermeiros, especialmente, na atenção primária, cenário privilegiado dos estudos primários sintetizados (ZOBOLI; SCHVEITZER, 2013, tela 7).

Dessa forma, podemos inferir que o ordenamento necessário para a prática do cuidado inclui o levantamento qualificado de necessidades como base de todo o processo de cuidar em Enfermagem.



Observação

Para contextualizar esta disciplina de *Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem*, destacamos a sua inserção enquanto prática social da Enfermagem e como parte do processo de cuidar sistematizado.

A avaliação clínica e psicossocial converge para a etapa inicial do processo de Enfermagem: a coleta de dados.

Vale então resgatar, conforme preconizado pelo Cofen, na Resolução nº 358/2009, em seu art. 1º, que "o processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem" (COFEN, 2009).

A mesma resolução, em seu segundo artigo, afirma que o processo de Enfermagem organiza-se em "cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes" (COFEN, 2009):

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

II – Diagnóstico de Enfermagem: processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de Enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

III – Planejamento de Enfermagem: determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de Enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

IV – Implementação: realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.

V – Avaliação de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de Enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009).



Lembrete

O processo de cuidar em Enfermagem, enquanto arte e ciência, requer competência técnica e científica permeada pela sensibilidade humana.



Saiba mais

Para aprofundar o conhecimento acerca das discussões anteriores, recomendamos a leitura na íntegra do seguinte artigo:

ZOBOLI, E. L. C. P.; SCHVEITZER, M. C. Valores da enfermagem como prática social: uma metassíntese qualitativa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 21, n. 3, 8 telas, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n3/pt_0104-1169-rlae-21-03-0695.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2018.

1.1 Promoção da saúde

Considerando a relevância da promoção da saúde como prática de cuidado e a necessidade de uma compreensão ampliada do ser humano em seus processos de produção e reprodução social para uma avaliação integral dele, apresentamos uma breve discussão acerca do conceito e dos desdobramentos da promoção da saúde.

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,

incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global (WHO, 1986, tradução nossa).

Em um movimento contrário para superar as abordagens tecnicistas e medicalizantes acerca dos problemas de saúde, temos as iniciativas de promoção da saúde, tais como definidas na Carta de Ottawa (WHO, 1986), que envolvem evidentes esforços interdisciplinares e intersetoriais. Dessa forma, o campo da promoção da saúde compõe um espaço de problematização e fomento às ferramentas analíticas e metodológicas com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a natureza dos processos de saúde, adoecimento e vulnerabilidades sociais (MAGALHÃES, 2016).

Existem diversas referências teórico-conceituais que discorrem sobre as práticas de promoção da saúde, entretanto, o eixo condutor comum é a crítica à ênfase excessiva dada à tecnologia médica e à alteração de comportamentos individuais como soluções para os desafios enfrentados (MAGALHÃES, 2016).

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (BRASIL, 2010) afirma que a análise do processo saúde-doença demonstra que a saúde é resultante das formas de organização da produção, do trabalho e da sociedade em um contexto histórico determinado. Afirma ainda que a estrutura biomédica não é capaz de modificar os condicionantes e os determinantes mais amplos desse processo. Essa estrutura atua a partir de um modelo de atenção e cuidado majoritariamente centrado nos sintomas.

A promoção da saúde pode ser compreendida como um mecanismo de fortalecimento e implementação de uma política transversal, integrada e intersetorial, capaz de dialogar com as diferentes áreas do setor sanitário, outros setores do governo, setor privado e não governamental e sociedade. Configura, dessa forma, redes de compromisso e corresponsabilidade no que se refere à qualidade de vida da população, com a participação de todos na proteção e no cuidado com a vida (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, a promoção da saúde desenvolve-se a partir da articulação entre sujeito e coletivo, público e privado, Estado e sociedade, clínica e política, setor sanitário e outros setores, almejando romper a fragmentação existente de forma evidente na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir a vulnerabilidade, riscos e danos produzidos nesse contexto (BRASIL, 2010).

Em 2014, por meio da Portaria nº 2.446, o Ministério da Saúde redefiniu a PNPS e apresentou o seguinte conceito de promoção da saúde:

A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela

articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social (BRASIL, 2014).

A reformulação da PNPS, articulada a um arranjo político, apresenta uma nova sistematização para as ações de promoção da saúde. Suas metas apontam para os novos desafios no contexto do Sistema Único de Saúde, apesar de constatar que suas prioridades ainda estão vinculadas à versão de 2006 da política. É esperado que, ao longo dos dez anos de existência da PNPS, novos desafios estejam direcionados para as arenas políticas com a finalidade de permear a assinatura – e a consequente concretização – de acordos favoráveis à sustentabilidade (ALBUQUERQUE; SÁ; ARAÚJO JÚNIOR, 2016).



Lembrete

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (BRASIL, 2010) afirma que a análise do processo saúde-doença demonstra que a saúde é resultante das formas de organização da produção, do trabalho e da sociedade em um contexto histórico determinado.

Na nova versão, os temas prioritários da PNPS, convergentes com o Plano Nacional de Saúde, pactos interfederativos e planejamento estratégico do Ministério da Saúde, além de acordos internacionais estabelecidos com o governo brasileiro, são:

I – Formação e educação permanente, que compreende mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde e incluí-la nos espaços de educação permanente.

II – Alimentação adequada e saudável, que compreende promover ações relativas à alimentação adequada e saudável, visando à promoção da saúde e à segurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e metas de redução da pobreza, com a inclusão social e com a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.

III – Práticas corporais e atividades físicas, que compreende promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre outras práticas.

IV – Enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, que compreende promover, articular e mobilizar ações para redução e controle do uso do tabaco, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.

V – Enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas, que compreende promover, articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e outras drogas, com a responsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.

VI – Promoção da mobilidade segura, que compreende:

a) buscar avançar na articulação intersetorial e intrasetorial, envolvendo a vigilância em saúde, a atenção básica e as redes de urgência e emergência do território na produção do cuidado e na redução da morbimortalidade decorrente do trânsito;

b) orientar ações integradas e intersetoriais nos territórios, incluindo saúde, educação, trânsito, fiscalização, ambiente e demais setores envolvidos, além da sociedade, visando definir um planejamento integrado, parcerias, atribuições, responsabilidades e especificidades de cada setor para a promoção da mobilidade segura; e

c) avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento integrado, que garantam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e a paz no trânsito;

VII – Promoção da cultura da paz e de direitos humanos, que compreende promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos, para o desenvolvimento de tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades e diferenças de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero, entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais, de classe social e relacionada às pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais, articulando a RAS com as demais redes de proteção social, produzindo informação qualificada e capaz de gerar intervenções individuais e coletivas, contribuindo para a redução das violências e para a cultura de paz; e

VIII – Promoção do desenvolvimento sustentável, que compreende promover, mobilizar e articular ações governamentais, não governamentais, incluindo o setor privado e a sociedade civil, nos diferentes cenários, como cidades, campo, floresta, águas, bairros, territórios, comunidades, habitações, escolas, igrejas, empresas e outros, permitindo a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável na produção social da saúde em articulação com os demais temas prioritários (BRASIL, 2015, p. 31-32).



Observação

Entender o conceito de promoção da saúde e sua premissa de olhar o processo saúde-doença para além do aspecto biológico, em uma inserção social complexa, direciona a compreensão da disciplina *Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem*, que preconiza avaliar o ser humano sempre inserido em um contexto ampliado.



Saiba mais

A leitura da PNPS em sua última versão é uma oportunidade de reflexão ampliada acerca deste tema:

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)*. Revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006. Brasília: MS, 2015. Disponível em: <http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/arquivos/pnps-2015_final.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2018.

1.2 Pensamento crítico e pensamento reflexivo

Pensamento crítico não é um método a ser aprendido, mas um processo, uma orientação da mente, incorporando os domínios afetivo e cognitivo (SIMPSON; COURTNEY, 2002).

O aprimoramento do pensamento crítico é fundamental para atingir metas de aprimoramento diagnóstico, já que a proposta de diagnósticos e intervenções é uma tarefa complexa. Quando utilizado, esse aprimoramento pode definir se os dados obtidos são confiáveis e suficientes, ou se são conflitantes ou insuficientes, a fim de determinar o diagnóstico mais acurado, bem como estabelecer os resultados esperados sensíveis às intervenções de Enfermagem e, por fim, intervenções de Enfermagem adequadas, sempre considerando a segurança do paciente (BENNER, 1984; CERULLO; CRUZ, 2010).

A existência de conflitos no local de trabalho, o uso estereotipado de categorias diagnósticas e a demanda excessiva sobre o tempo dos enfermeiros podem ser barreiras ao melhor pensamento crítico (HYNES; BENNETT, 2004).

Na avaliação do paciente, o pensamento crítico pode analisar se os resultados foram alcançados, se houve falhas nesse processo. Uma prática baseada no pensamento crítico propicia atos justificados (BARROS *et al.*, 2015).

De acordo com Forneris (2004, p. 26), o pensamento crítico tem quatro atributos:

Reflexão: como um processo crítico, discrimina o que é relevante e determina a razão das ações.

Contexto: inclui cultura, fatos, conceitos, regras, princípios e pressupostos que moldam o modo de construção do conhecimento. É atributo para a compreensão.

Diálogo: por meio do diálogo, a situação é moldada de forma reflexiva para gerar o entendimento.

Tempo: a noção de tempo indica que a aplicação prévia da aprendizagem tem impacto sobre a ação futura.

O aprimoramento do raciocínio clínico é um constante desafio para todos os profissionais da área de saúde, principalmente para os enfermeiros. Essa prática exige utilização de múltiplas estratégias e formação permanente do profissional (CERULLO; CRUZ, 2010).



Observação

Ao fazer suas pesquisas, procure trabalhos que tenham como foco a discussão de casos e estudos sobre o aprimoramento do raciocínio clínico, comparando as respostas psicossociais com as fisiológicas.

Os onze Padrões Funcionais de Saúde são áreas que permitem a compreensão dos processos de saúde e doença: percepção e manejo da saúde, nutricional-metabólico, eliminação, atividades e exercícios, sono e repouso, percepção sensorial, autopercepção e autoconceito, relacionamentos, sexualidade e reprodução, adaptação e tolerância ao estresse, crenças e valores. Trata-se de abordagem estruturada e holística para a avaliação de admissão da pessoa, sua evolução e sua qualidade de vida (GORDON, 1994).



Saiba mais

A realização de uma anamnese qualificada associada ao exame físico acurado possibilita o desenvolvimento do raciocínio clínico e psicossocial a partir de um pensamento crítico. Para tanto, vale a seguinte leitura, com a finalidade de introduzir a ideia de pensamento crítico:

CERULLO, J. A. S. B.; CRUZ, D. A. L. M. Raciocínio clínico e pensamento crítico. *Rev. Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 18, n. 1, 6 telas, 2010.

2 AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A avaliação psicossocial integrada à avaliação clínica proporciona ao profissional de saúde um olhar integral para o ser humano. Existe uma herança histórica, ancorada no paradigma positivista, de aprofundamento no conhecimento da dimensão biológica do ser humano. Entretanto, em conformidade com o paradigma da complexidade, vemos emergir gradativamente a valorização da dimensão psicossocial, sem a qual não é possível responder às complexas demandas do ser humano.

O cuidado com a saúde das pessoas envolve atenção para diversos aspectos de natureza psicossocial. Identificar a presença de tais aspectos, conhecer sua magnitude e compreender suas relações é fundamental para o adequado atendimento por qualquer profissional de saúde (MOTA; PIMENTA, 2007, p. 310).

Mota e Pimenta (2007) informam que pesquisadores, com o objetivo de avaliar conceitos sob uma nova perspectiva, incluindo novas dimensões não exploradas, ou ainda aperfeiçoar um instrumento já existente, têm trabalhado na construção de novas possibilidades de medida. Se, no passado, fenômenos subjetivos tais como fadiga, dor, autoeficácia, depressão e qualidade de vida eram considerados sem possibilidade de mensuração, encontramos, na atualidade, à disposição diversos instrumentos para esse tipo de avaliação. O desafio está em incorporá-los à prática clínica e à pesquisa em Enfermagem, visando aperfeiçoá-los.

Esse novo caminho, em busca de instrumentos que considerem a subjetividade humana, é reflexo de um movimento de resgate da complexidade do ser humano, que durante muito tempo ficou submetido a uma avaliação objetiva e materialista, em conformidade com a racionalidade biomédica de compreensão do ser humano em seu aspecto orgânico e biológico (SOUTO; PEREIRA, 2011).

A literatura relata que a abordagem clínica no século XX foi permeada pela incorporação de uma prática materialista, desenvolvida a partir da racionalidade biomédica centrada no orgânico. Nesse sentido, a doença é relacionada prioritariamente a um efeito anatômico, bioquímico ou fisiológico (SANVITO, 2009; SOUTO; PEREIRA, 2011).

Essa forma de abordagem clínica levou à utilização abusiva de insumos de finalidade biomédica na atenção aos problemas de saúde e à subtração do aproveitamento de tecnologias de cuidado voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida. Além disso, não valorizou o princípio da equidade. Houve, dessa forma, uma dicotomia entre o sujeito e a vida na vivência do processo de cuidado à saúde, o que reduziu a abordagem das necessidades clínicas aos limites do corpo biológico (FONSECA; KIRST, 2004; SOUTO; PEREIRA, 2011).

Como resultado dessa forma de abordagem, foram evidenciadas as dificuldades em lidar com fenômenos subjetivos do indivíduo que demanda cuidado e, assim, ocorreu um movimento de resgate da clínica com foco no sujeito, de forma a suscitar vida ao vivo e o sentido de ser à pessoa. Para isso, foi iniciado um processo de estabelecimento de diagnósticos que ultrapassam a dimensão biomédica, bem como de prescrições objetivas. Trata-se de alcançar uma prática que aborde o espaço da existência, extrapolando os objetos em termos de vida e morte, adotando uma estratégia que identifica as necessidades de saúde e propõe planos de cuidado de modo ampliado e integral (FONSECA; KIRST, 2004; SOUTO; PEREIRA, 2011).

A saúde envolve aspectos de essência integradora, inter-relacional e multidimensional e permeia múltiplas dimensões do ser humano: biológicas, sociais, psicológicas, espirituais, dentre outras. Essas dimensões se inter-relacionam com o ambiente no qual as pessoas se encontram e que pode demandar o atendimento em saúde com foco no equilíbrio e na sustentabilidade (CAPRA, 2002; ZAMBERLAN *et al.*, 2013).

A inter-relação entre ambiente, saúde e Enfermagem é uma constante no ecossistema onde o enfermeiro está inserido. As ações em saúde necessitam, fundamentalmente, ser pautadas considerando os ambientes onde o ser humano está agregado, bem como a rede de interações e relações que ele construiu ao longo da vida, visto que a relação dele com o meio gera repercussões no seu pensar, agir e sentir (ZAMBERLAN *et al.*, 2013, p. 606).

Incluir ações ecossistêmicas no cotidiano de trabalho do enfermeiro envolve o atendimento integral ao ser humano, uma vez que tem a oportunidade de adotar ações que abrangem aspectos ambientais, ecológicos, físicos, psicológicos, sociais e espirituais, criando, desse modo, possibilidades de um cuidado integrativo e inter-relacional. Destaca-se ainda a concepção de cuidado inserida na interação com o ambiente. Refletir na perspectiva ecossistêmica é, essencialmente, religar saberes, favorecer flutuações em diversos campos do conhecimento, promover a auto-organização e, em especial, propiciar a sustentabilidade dos sistemas vigentes (ZAMBERLAN *et al.*, 2013).



Figura 1 – Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead

A Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de promover em nível internacional o reconhecimento da relevância dos determinantes sociais, bem como o combate das iniquidades em saúde desencadeadas por esses determinantes, estabeleceu a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde em 2005 (WHO, 2008). Nesse mesmo ano, o governo brasileiro fundou a sua Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), promovendo esse debate em âmbito nacional. Além disso, divulgou um relatório, fruto de discussões dessa comissão (CNDSS, 2008).

A CNDSS propôs, nesse relatório, a utilização de um modelo conceitual de determinação social da saúde, que estratifica os determinantes em diferentes eixos: os macrodeterminantes, referentes às

condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, bem como os determinantes proximais, a exemplo de estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo e fatores hereditários. Além disso, a CNDSS também estabeleceu um conjunto de indicadores relacionados aos diversos determinantes sociais. Destaca-se, porém, a restrição na discussão da temática ambiental.

O estabelecimento da CNDSS representou um avanço para o resgate de estudos que envolvem o tema dos determinantes sociais na área da saúde, entretanto, apresentou uma limitação ao não discorrer acerca da articulação dos indicadores sociais e econômicos com o meio ambiente (SOBRAL; FREITAS, 2010).

Nesse sentido, os mesmos autores propõem, para viabilizar a operacionalização da análise dos determinantes sociais da saúde (DSS) a partir de um conjunto de indicadores integrados, a utilização do modelo de organização ou sistema de indicadores chamado de Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-Efeito-Ação (FPSEEA). Esse modelo foi elaborado pela OMS, em coparceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), com a finalidade de abordar as inter-relações entre os fatores ambientais e a saúde (SOBRAL; FREITAS, 2010; CORVALÁN; BRIGGS; KJELLSTRÖM, 1996).

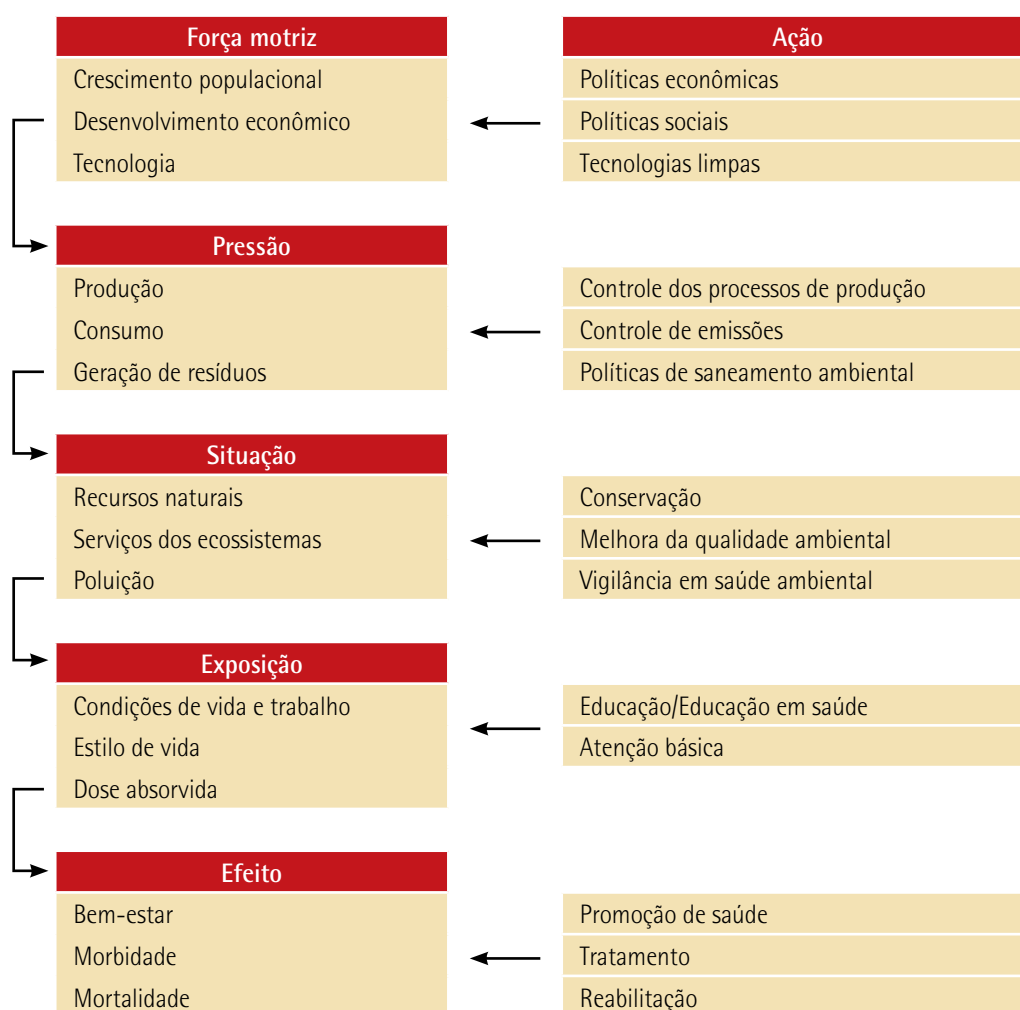


Figura 2 – Modelo de organização de indicadores FPSEEA



Observação

Sobral e Freitas (2010) destacam que tão significativo quanto reconhecer a importância dos DSS e realizar um diagnóstico da situação a partir de indicadores é executar uma abordagem que integre todos os indicadores aos âmbitos econômico, social, ambiental, institucional e de saúde, para, assim, possibilitar um monitoramento sistemático das alterações das condições de vida e da situação de saúde da população.

Incluir o paradigma holístico no processo de cuidar em saúde emerge amplamente dentro do contexto da humanização e está imbuído das prerrogativas do SUS, em especial, a da integralidade (LEMOS *et al.*, 2010).



Saiba mais

A leitura dos DSS enriquecerá a sustentação teórica para a compreensão do ser humano inserido em um cenário permeado de fatores que interferem direta e indiretamente na sua condição de saúde:

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (CNDSS). *As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

2.1 Consulta de Enfermagem

Conforme estabelecido pelo Cofen, na Resolução nº 358/2009, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, quando o processo de Enfermagem é desenvolvido em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, dentre outros, é chamado de consulta de Enfermagem (CE). A CE é, portanto, a prática do processo de Enfermagem realizada fora do ambiente hospitalar. A consulta deve, dessa forma, seguir todas as etapas estabelecidas pelo Cofen, conforme discutido no início deste livro-texto, e deve ser permeada de conhecimentos, habilidades e atitudes que se traduzam em um cuidado de qualidade.

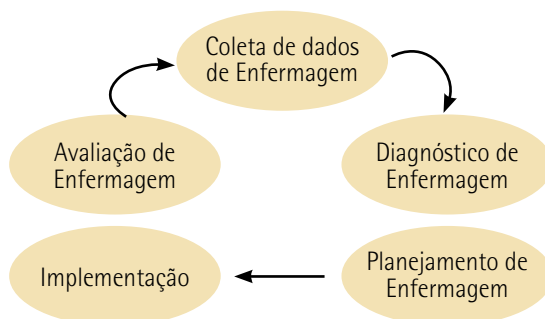


Figura 3 – Processo de Enfermagem

A prática de cuidar em Enfermagem demanda a utilização de muitas tecnologias. Destaca-se, em especial na atenção primária à saúde (APS), a execução da CE, que envolve a combinação de conhecimento humano, científico e empírico. A CE sistematiza a ação cotidiana do enfermeiro com o intuito de ofertar uma assistência qualificada e que se realiza no ato de cuidar do indivíduo/família/comunidade. Cabe destacar que ela está permeada por questões éticas e pelo processo reflexivo (MEIER *et al.*, 2008; DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016).

Observação

Constatamos que, uma vez que as relações interpessoais permeiam o cotidiano de trabalho do enfermeiro, a tecnologia para o cuidado supera o caráter técnico-científico. Nesse contexto, os resultados atingidos podem ser subjetivos e abstratos (MEIER *et al.*, 2008; DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016).

Dantas, Santos e Tourinho (2016) destacam, nesse sentido, que haverá, na CE, uma relação entre três elementos: o levantamento de dados, a análise e o plano de cuidados, os quais podem ser desenvolvidos em quatro passos: avaliação, diagnóstico de Enfermagem, intervenção ou implementação, e evolução.

Essa prática exige que o enfermeiro tenha **ancoragem de conhecimento teórico-prático, bem como criatividade e sensibilidade**. Deve ocorrer de forma ativa, sistemática e contínua para que, assim, torne-se possível identificar a quantidade e a qualidade dos cuidados de Enfermagem necessários para acompanhar o ser humano na vivência do seu processo saúde-doença (AMANTE *et al.*, 2010).

Dantas, Santos e Tourinho (2016) destacam ainda que as tecnologias são fundamentais para o trabalho do enfermeiro. Em especial na CE, o diálogo, enquanto uma tecnologia, apresenta-se como elemento de destaque. Nesse cenário, a subjetividade do enfermeiro e do sujeito se expressam, por isso é fundamental a criação e consolidação de vínculo entre ambos.

Assim, a utilização das tecnologias leves que se manifestam na dimensão relacional, para muitos profissionais, ainda é um desafio. Especificamente na APS, nas unidades de saúde, em que o enfermeiro tem múltiplas atividades burocráticas, torna-se comum que a CE fique em segundo plano. Além disso, muitos profissionais não estão qualificados para interagir com o usuário utilizando a comunicação terapêutica ou estão arraigados numa prática cartesiana. Em síntese, as tecnologias são um meio para que o enfermeiro preste um cuidado humanizado, com foco na melhoria da qualidade de vida do sujeito. Para o alcance dessa meta, o profissional necessita comprometer-se com sua prática, buscando aprimorar constantemente seus conhecimentos (DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016).

Os enfermeiros precisam depreender que o cuidado e a tecnologia estão interligados, pois a Enfermagem está comprometida com princípios, leis e teorias. Portanto, a tecnologia consiste na expressão desse conhecimento científico e em sua própria transformação enquanto ciência, de modo que a filosofia tem um papel de suma relevância,

que é possibilitar ao profissional refletir de forma crítica e participativa sobre o seu fazer. A CE deve ser uma prática sistematizada, estruturada cientificamente e que utilize uma linguagem unificada de Enfermagem, oportunizando a comunicação e a documentação da sua prática, favorecendo a promoção, proteção e manutenção da vida, bem como a melhoria na qualidade da atenção prestada à pessoa, família e comunidade (DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016, p. 7-8).

Um estudo conduzido por Machado, Oliveira e Manica, que teve como objeto a consulta de Enfermagem ampliada e fundamentada nas prerrogativas da clínica ampliada (que transfere a ênfase das ações de cuidar/educar da doença para centrá-las nos usuários e em suas necessidades de saúde), revelou que práticas pedagógicas ancoradas no conceito ampliado de saúde produziram saberes que superaram aqueles comumente aprendidos no ensino tradicional da CE. Houve coerência com a formação para a integralidade, por exemplo (MACHADO; OLIVEIRA; MANICA, 2013):

- as prioridades de intervenções eleitas pelo profissional e as percebidas pelo usuário nem sempre coincidem;
- a escuta é uma tecnologia que possibilita o acesso a situações de vida dos usuários dificilmente reveladas na consulta tradicional;
- a informalidade do encontro profissional/usuário favorece o vínculo e torna viável a participação do usuário na produção do plano terapêutico.



Observação

Na CE, ocorre o encontro entre profissional de saúde e usuário do serviço. Esse encontro pode conter a potência micropolítica de transformação. Transformação do profissional e do usuário na forma de conduzir suas ações. A potência do encontro dependerá: do vínculo estabelecido, da comunicação desenvolvida, da competência técnica, ética e estética estabelecida, dentre outros fatores. A consciência que o profissional enfermeiro deve ter em relação a sua responsabilidade nesse encontro com o outro terá impacto na qualificação ou não do serviço prestado e, principalmente, na vida que terá sido (ou não) cuidada naquele momento.

As tecnologias e ferramentas estão postas; cabe ao profissional a decisão de agir com compromisso e competência.

Complementando as evidências até aqui apresentadas, temos outro estudo desenvolvido por Souza *et al.* (2013), que identificou a percepção dos usuários dos serviços de saúde acerca da CE. Os resultados indicaram que os usuários percebem o enfermeiro como um profissional da saúde capaz de realizar uma abordagem acolhedora. A população atendida percebe a aproximação e a

valorização do diálogo, que possibilita a expressão de suas necessidades de saúde de maneira mais fácil. Além disso, foi constatado o estabelecimento de vínculo e confiança entre profissional e usuário, com destaque para o reconhecimento do usuário como sujeito ativo na promoção de sua qualidade de vida. Ainda como evidência desse estudo, os usuários dos serviços de saúde percebem que o enfermeiro utiliza a comunicação como ferramenta de educação em saúde e motiva o sujeito a refletir sobre suas escolhas, estimulando a crítica sobre seu processo de saúde com autonomia (SOUZA *et al.*, 2013).



Saiba mais

Indicamos a leitura do seguinte artigo:

OLIVEIRA, S. K. P. *et al.* Temas abordados na consulta de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 65, n. 1, p. 155-161, 2012.

Exemplo de aplicação

Para ampliar seus conhecimentos e unir o conteúdo teórico com a prática, leia:

DUARTE, M. de L. C.; NORO, A. Humanização: uma leitura a partir da compreensão dos profissionais da enfermagem. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre (RS), v. 31, n. 4, p. 685-692, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n4/a11v31n4.pdf>>. Acesso em: 2 mar. 2019.

Qual a relação da humanização e da qualidade de uma avaliação clínica e psicossocial?

O que significa "transcender a fragmentação do cuidado desde a formação dos profissionais de saúde"?

Como a comunicação pode propiciar um cuidado humanizado?

Escreva com suas palavras o que compreendeu desse artigo e faça uma correlação com o conteúdo estudado neste livro-texto.



Resumo

Apresentamos ao leitor reflexões e subsídios teóricos acerca da Enfermagem enquanto prática social. Essa prática de inserção evidentemente social converge para o conceito de promoção da saúde, que compreende o processo saúde-adoecimento do ser humano como um fenômeno resultante de determinantes sociais historicamente construídos. Há uma complexidade no olhar para o ser humano e o seu modo de vida e inserção social.

Dessa forma, o profissional enfermeiro deve estar disponível e capacitado para ter esse olhar ampliado do ser humano, família e comunidade que receberá os seus cuidados.

Em conformidade com a necessária organização do processo de cuidar em Enfermagem, devemos considerar a importância de sistematizar o cuidado, não como forma de "engessamento" e padronização rígida, mas sim enquanto estratégia de organização e otimização de um cuidado pautado na competência técnica e na habilidade de relacionamento humano.

Ressaltamos que, como parte do processo de cuidar em Enfermagem, a avaliação clínica e psicossocial compõe a fase inicial de coleta de dados, sendo, portanto, o disparador de todo o processo e, por isso, requer competência científica e humana para um cuidado efetivo e de qualidade.

Esta unidade teve ainda como finalidade levar o leitor a refletir sobre a atuação do enfermeiro em um contexto ampliado de inserção do ser humano no mundo. Em contraposição ao modelo biomédico que compreende a pessoa e seu processo saúde-doença apenas a partir das dimensões biológicas, trabalhamos a perspectiva ampliada de concepção da vida humana e suas respostas aos diferentes determinantes sociais de saúde.

Em um movimento de superação à concepção cartesiana do cuidado em saúde, a Organização Mundial da Saúde inicia um movimento de repercussão internacional para discutir os determinantes sociais da saúde e as iniquidades existentes que impactam a saúde da população. Essa discussão reverbera no Brasil com o estabelecimento da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.

Reconhecemos os avanços nas discussões, entretanto, são muitos os desafios e as limitações ainda presentes para que a mudança de paradigma se traduza em prática amplamente disseminada nos serviços de saúde.

Na lógica de olhar ampliado para o ser humano, esta unidade apresentou ainda a consulta de Enfermagem (CE), que se trata de uma tecnologia potente para o processo de cuidar do enfermeiro e, também, de um desafio para ultrapassar o perfil majoritariamente clínico e biológico utilizado nesse espaço de encontro entre profissional de saúde e usuário dos serviços. Para que o encontro tenha possibilidade de um impacto micropolítico de qualificação da assistência e na qualidade de vida da pessoa, o profissional necessita de habilidades técnicas e humanas: ética e estética, num processo ordenado, sistematizado, mas que requer um raciocínio clínico e, principalmente, psicossocial.



Exercícios

Questão 1. (UFSC 2018, adaptada) Considerando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), analise as afirmativas a seguir:

I – O processo de enfermagem, de acordo com a Resolução Cofen nº 358/2009, é estruturado nas etapas de coleta de dados (histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, implantação e avaliação de enfermagem.

II – Nas teorias de enfermagem, que devem ser um referencial para a SAE, os conceitos de Enfermagem, Cuidado, Saúde e Ambiente compõem o metaparadigma da enfermagem e ilustram o público receptor dos cuidados de enfermagem e a finalidade da assistência de enfermagem.

III – A Resolução Cofen nº 358/2009 preconiza que o técnico e o auxiliar de enfermagem realizem todas as etapas do Processo de Enfermagem.

IV – A educação permanente dos profissionais de enfermagem é necessária a fim de que a SAE seja incorporada à prática.

V – A SAE favorece a melhoria da prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade.

É correto apenas o que se afirma em:

A) I e IV.

B) IV e V.

C) II e V.

D) III e V.

E) I e III.

Resposta correta: alternativa B.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa incorreta.

Justificativa: o processo de enfermagem é estruturado nas seguintes etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.

II – Afirmativa incorreta.

Justificativa: nas teorias de enfermagem, que devem ser um referencial para a SAE, os conceitos de Pessoa, Ambiente, Saúde e Enfermagem compõem o metaparadigma.

III – Afirmativa incorreta.

Justificativa: segundo o art. 4º: ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem (PE), de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas.

IV – Afirmativa correta.

Justificativa: os enfermeiros precisam, cada vez mais, de conhecimentos acerca das teorias de enfermagem, de processo de enfermagem, de semiologia, de fisiologia, de patologia, além das habilidades necessárias para gerenciarem as unidades efetivamente. É importante ressaltar que, para que a SAE seja incorporada à prática, é necessária uma educação permanente de todos os profissionais envolvidos no processo.

V – Afirmativa correta.

Justificativa: os enfermeiros necessitam de instrumentos que favoreçam a implantação das etapas do PE na prática, tais como impressos para auxiliar na coleta e no registro dos dados do indivíduo, da família ou da comunidade e/ou *softwares* que os auxiliem na execução das etapas do método científico. A partir dos estudos de Horta (1979), no fim da década de 1960, foi que a atenção dos enfermeiros brasileiros começou a ser direcionada para a SAE e enfatizou-se o planejamento da assistência, na tentativa de tornar autônoma a profissão e de caracterizá-la como ciência, por meio da implementação da SAE.

Questão 2. (Enade 2013, adaptada) A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Portaria nº 3.088/2011, busca instituir, no âmbito do SUS, a rede de atenção psicossocial a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e necessidades decorrentes do uso de *crack*, álcool e outras drogas. Nesse contexto, constitui objetivo da rede de atenção psicossocial:

I – Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso de *crack*, álcool e outras drogas e de suas famílias aos pontos de atenção.

II – Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

